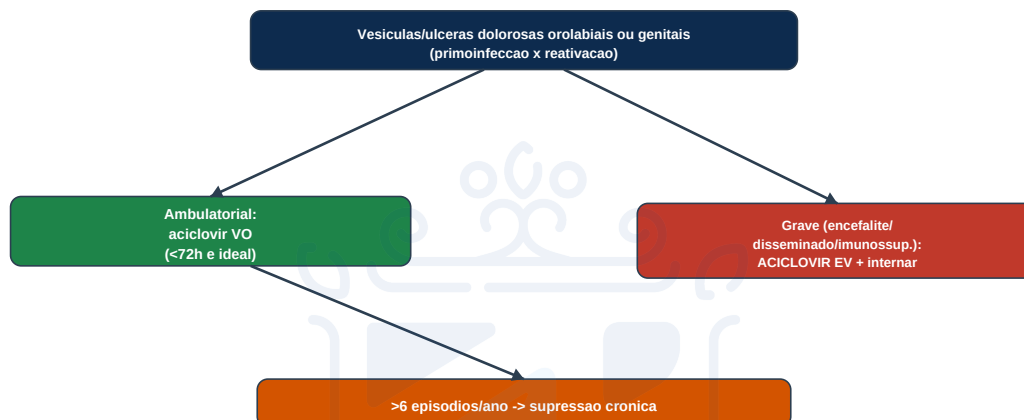


HERPES SIMPLES — HSV-1/2 + ACICLOVIR

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

HSV — LESÕES VESICULARES -> ANTIVIRAL SISTÊMICO



DEFINIÇÃO E MANIFESTAÇÕES

PRIMOINFECÇÃO x REATIVAÇÃO

- HSV-1 (predileção orolabial) e HSV-2 (predileção genital), mas ambos podem afetar qualquer compartimento; doença = primoinfecção + reativações
- Orolabial: primoinfecção na infância (gengivostomatite herpética, faringite, febre, linfadenopatia); reativação = lesões labiais vesiculares dolorosas, precedidas por pródromo (dor/parestesia) em ~80%
- Genital: primoinfecção no início da vida sexual (frequentemente assintomática); quando sintomática, pápulas/vesículas/úlceras dolorosas, fissuras, disúria, sintomas sistêmicos em ~50%
- Reativação genital: pródromo em metade dos casos, com duração/intensidade menores que a primoinfecção
- Recorrente: > 4-6 episódios/ano

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO / SINDRÔMICO

- Diagnóstico CLÍNICO (sindrômico) na apresentação clássica — validado e preconizado pelo MS/OMS
- PCR (swab da lesão): especificidade ~100%, melhor sensibilidade em lesões recentes (< 5 dias, em fase de vesícula) — para casos atípicos
- Esfregaço de Tzanck: mostra efeito citopático (sensibilidade 60-80%), mas NÃO diferencia HSV de varicela-zoster
- Sorologia: IgM SEM utilidade; IgG HSV-1 não recomendado (maioria já positiva); IgG HSV-2 tem papel em dúvida diagnóstica (positiva ~12 semanas) ou recorrência com PCR negativo
- Rastreamento sorológico na população geral NÃO é recomendado

TRATAMENTO ANTIVIRAL

Rx EPISÓDICO x SUPRESSIVO

Antiviral sistêmico recomendado na maioria dos sintomáticos (primoinfecção ou reativação): controla parcialmente os sintomas e reduz a duração, sobretudo se iniciado nas primeiras 72h

Opções: Aciclovir, Valaciclovir ou Famciclovir (eficácia similar; nenhum erradica o vírus latente)

No SUS, o aciclovir (comp. 200 mg) é a medicação disponível; valaciclovir/famciclovir têm melhor posologia, porém mais caros

Tópico (pomada de aciclovir) NÃO tem benefício clínico — não recomendado

RECORRÊNCIA: tratamento episódico (reduz intensidade/duração de cada surto) OU supressivo crônico (reduz 70-80% das recorrências)

Supressão crônica: considerar se > 6 episódios/ano; reavaliar anualmente (drogas muito seguras, sem necessidade de monitorar eventos adversos)

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO / GRAVIDADE

ACICLOVIR EV

- ENCEFALITE HERPÉTICA (alteração de consciência, convulsões, sinais focais) ou meningite grave — emergência, ACICLOVIR EV
- HSV DISSEMINADO (hepatite, pneumonite, coagulopatia), comum em imunossuprimidos
- Imunossupressão grave com lesões extensas/necróticas ou sem resposta à VO
- Complicações oculares (necrose retiniana aguda, ceratite grave) e ECZEMA HERPÉTICO (sobre dermatite atópica — risco de sepse)
- Gengivostomatite grave impedindo hidratação/nutrição (especialmente crianças); impossibilidade de absorção oral

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com lesões herpéticas ____ (orolabial/genital/disseminado); primoinfecção/reativação; início há ____.
- Gravidade: encefalite (consciência/convulsão/foco) ____, disseminação ____, imunossupressão ____, eczema herpético ____.
- Conduta: Aciclovir ____ (VO/EV, dose ____) iniciado às ____; suporte ____.
- Solicito internação para Aciclovir EV / investigação de encefalite (PCR liquor + TC) / suporte; isolamento de contato.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o tratamento de escolha (disponível no SUS) para herpes simples sintomático?

- A) Aciclovir tópico isolado
- B) Aciclovir sistêmico (VO), idealmente nas primeiras 72h
- C) Antibiótico oral
- D) Corticoide
- E) Apenas observação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quando considerar a terapia supressiva crônica no herpes simples recorrente?

- A) Em todos os pacientes
- B) Quando há mais de 6 episódios por ano (reavaliar anualmente)
- C) Apenas na primoinfecção
- D) Somente em gestantes
- E) Nunca

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual exame tem alta especificidade para confirmar HSV em lesões atípicas?

- A) Sorologia IgM
- B) PCR (swab da lesão), melhor em vesículas recentes
- C) Hemocultura
- D) Esfregaço de Tzanck isolado
- E) Cultura de urina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual situação exige aciclovir endovenoso e internação?

- A) Herpes labial recorrente leve
- B) Encefalite herpética (alteração de consciência, convulsões, sinais focais)
- C) Pródromo de dor labial
- D) Lesão genital única em imunocompetente
- E) Recorrência anual única

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o tratamento tópico (pomada de aciclovir) no herpes simples, é correto:

- A) É a primeira escolha
- B) Não tem benefício clínico e não é recomendado
- C) Substitui o tratamento sistêmico na encefalite
- D) Erradica o vírus latente
- E) É superior ao oral

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O aciclovir sistêmico (VO) é o tratamento de escolha disponível no SUS, idealmente iniciado nas primeiras 72h; valaciclovir/famciclovir têm eficácia similar e melhor posologia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A supressão crônica é considerada quando há mais de 6 episódios por ano, reduzindo 70-80% das recorrências; a decisão é reavaliada anualmente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A PCR (swab da lesão) tem especificidade próxima a 100% e melhor sensibilidade em lesões recentes (vesículas), sendo útil em casos atípicos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A encefalite herpética é emergência que exige aciclovir EV e internação; outras indicações de EV incluem HSV disseminado, imunossupressão grave e eczema herpético.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O aciclovir tópico não tem benefício clínico e não é recomendado; o tratamento eficaz é o sistêmico, e nenhum antiviral erradica o vírus latente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico